

TEMA 7.8 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos del Ánimo: Trastorno Adaptativo y Distimia

PERFIL EUNACOM 1.11.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

En el espectro de los trastornos del ánimo, existen cuadros que, aunque no siempre cumplen los criterios estrictos de una depresión mayor, generan un malestar significativo y requieren intervención clínica. Este artículo aborda el **Trastorno Adaptativo** y la **Distimia**, dos patologías frecuentes en la práctica general y con alta rentabilidad en el examen EUNACOM.

Trastorno Adaptativo

El trastorno adaptativo es una respuesta psicológica a uno o más **estresores identificables** (eventos gatillantes) que se manifiesta mediante síntomas emocionales o conductuales clínicamente significativos.

Clínica y Clasificación

La clínica siempre viene precedida por un evento que genera angustia o estrés en la vida del paciente. Según el predominio de los síntomas, se clasifica en: - **Tipo Depresivo:** Predomina el ánimo bajo, llanto o desesperanza. - **Tipo Ansioso:** Predomina el nerviosismo, preocupación o agitación. - **Tipo Mixto:** Presenta una combinación de síntomas ansiosos y depresivos. warning Un error común es no tratar la distimia por considerarla "menos grave" que una depresión. La importancia del diagnóstico radica en que son pacientes que llevan años siendo infelices y cuya calidad de vida mejora significativamente con antidepresivos. :::

Próximo tema recomendado: Trastorno Bipolar

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 45 años, cuya hija de 20 años se fue a estudiar al extranjero hace 10 días, consulta por tristeza, llanto frecuente y sensación de vacío. El peso y el sueño están sin cambios. Está esperanzada en poder visitarla pronto. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos del Ánimo: Trastorno Adaptativo y Distimia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El trastorno adaptativo requiere un gatillante claro, síntomas menores a los de una depresión y presencia de esperanza.
- El trastorno adaptativo no requiere antidepresivos; se trata con psicoterapia centrada en la crisis.
- La distimia dura mínimo 2 años en adultos (1 año en niños) con ánimo bajo que no llega a depresión mayor; se trata igual que la depresión.
- La "depresión doble" = distimia (>2 años) + episodio de depresión mayor superpuesto.
- El duelo normal no cumple criterios de ningún trastorno psiquiátrico; puede durar hasta 2 años (muerte de pareja o hijo).
- Los cambios en peso/sueño e ideación de muerte orientan a depresión reactiva, no a trastorno adaptativo.
- La esperanza preservada ("confío en encontrar trabajo nuevo") es un elemento que orienta a trastorno adaptativo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DEL ÁNIMO: TRASTORNO ADAPTATIVO Y DISTIMIA)**PREGUNTA 1**

Mujer de 45 años, cuya hija de 20 años se fue a estudiar al extranjero hace 10 días, consulta por tristeza, llanto frecuente y sensación de vacío. El peso y el sueño están sin cambios. Está esperanzada en poder visitarla pronto. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Depresión mayor reactiva
- B)** Trastorno adaptativo de tipo depresivo
- C)** Duelo normal
- D)** Distimia
- E)** Depresión psicótica

PREGUNTA 2

Hombre de 38 años consulta porque lleva 3 años sintiéndose "apagado, sin ánimo, sin ganas de hacer cosas", sin tristeza franca ni anhedonia completa. No ha tenido episodios de depresión mayor. Duerme y come bien. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo?

- A)** Trastorno adaptativo crónico; psicoterapia
- B)** Depresión mayor en remisión parcial; mantener antidepresivos
- C)** Distimia; exámenes para descartar causa orgánica, ISRS y psicoterapia
- D)** Hipotiroidismo; levotiroxina
- E)** Trastorno de personalidad; psicoterapia sin fármacos

PREGUNTA 3

Paciente de 70 años cuyo hijo murió de cáncer hace 3 meses llora todo el día, no sale de su casa, refiere sentirse culpable de la muerte de su hijo "porque no lo cuidé bien". Los hijos confirman que los cuidados fueron excelentes. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Duelo normal; no requiere tratamiento
- B)** Trastorno adaptativo; psicoterapia
- C)** Depresión reactiva, posiblemente con depresión psicótica
- D)** Esquizofrenia de inicio tardío
- E)** Distimia; ISRS

RESUMEN: TRASTORNOS DEL ÁNIMO: TRASTORNO ADAPTATIVO Y DISTIMIA

El trastorno adaptativo es una respuesta psicológica a un evento estresante identificable (gatillante) que no cumple criterios de depresión ni de otro trastorno específico. Se divide en de tipo depresivo, ansioso o mixto. Sus características distintivas frente a la depresión reactiva son: menor intensidad de los síntomas, ausencia de cambios significativos en el peso o el sueño, presencia de esperanza ("se siente esperanzado de que mejorará"), y ausencia de ideación suicida. El tratamiento es psicoterapia cognitivo-conductual enfocada en el manejo de la crisis específica, sin requerir fármacos salvo excepciones. Los gatillantes se clasifican en normativos (salida del colegio, primer trabajo, tener hijos, partida de hijos, muerte de padres) y no normativos (enfermedad grave, muerte de un hijo, despido después de muchos años). El duelo normal se distingue del trastorno adaptativo por no cumplir criterios de ningún trastorno psiquiátrico, pudiendo durar hasta 2 años en casos de muerte de pareja o hijo. La distimia (o depresión menor) se caracteriza por ánimo bajo persistente durante al menos 2 años en adultos (1 año en niños y adolescentes), sin cumplir criterios completos de depresión mayor. El ánimo disfórico (sensación de no estar bien sin tristeza franca) es característico. Su tratamiento es idéntico al de la depresión: exámenes para descartar causa orgánica, antidepresivos ISRS y psicoterapia. La importancia del diagnóstico radica en que requiere tratamiento activo aunque no cumpla criterios de depresión mayor. La "depresión doble" ocurre cuando un paciente con distimia desarrolla adicionalmente un episodio de depresión mayor. El manejo diferencial entre trastorno adaptativo y depresión reactiva es fundamental: en el adaptativo se omiten los fármacos; en la depresión reactiva se agregan antidepresivos desde el diagnóstico. Los elementos que orientan a depresión reactiva son: cambios en el peso, insomnio significativo, tristeza muy intensa y desesperanza marcada o ideas de muerte.